

INFORMACIÓN CLÍNICA REQUERIDA EN IBF O EN INFORMES COMPLEMENTARIOS

Diagnostico	Información Requerida	Rescatar	Origen
ACV secuelado	Méd. Gral./Esp. y/o T.O., Klgo., Flgo., Psic. o Enf. Describe tipo y fecha del ACV, causa, evolución, tratamientos y rehabilitación realizada o pendiente. Debe especificar secuelas motoras, sensitivas, cognitivas, visuales, conductuales, del lenguaje, habla o deglución; alteraciones de marcha y equilibrio; dependencia en actividades de la vida diaria y asistencia de terceros.	-Epicrisis -Ayuda Técnica -Índice de Barthel -Índice de Lawton y Brody -Escala de Rankin modificada	Dependiendo de la secuela
Amputaciones	Méd. Gral./Esp. y/o T.O., Klgo., Flgo., Psic. o Enf. Debe describir causa, fecha, extremidad, lateralidad y nivel anatómico de la amputación; estado, dolor residual o fantasma, uso y adaptación de prótesis, ayudas técnicas y rehabilitación. Debe señalar limitaciones que esta produce.	-Epicrisis o Protocolo Operatorio -Ayuda técnica que utiliza.	FÍSICO
Artrosis	Méd. Gral./Esp. y/o T.O., Klgo., Flgo., Psic. o Enf. Debe aportar antecedentes clínicos que describan articulación comprometida, lateralidad, tiempo de evolución, gravedad, dolor, rigidez, limitación del rango articular, deformidades, alteración de fuerza, marcha y equilibrio; tratamientos realizados, respuesta, cirugías indicadas o pendientes.	- Informe imagenológico de la articulación afectada. - Epicrisis o Protocolo Operatorio -Ayuda Técnica	FÍSICO
Cáncer	Méd. Gral./Esp. y/o T.O., Klgo., Flgo., Psic. o Enf. Debe aportar informe oncológico actualizado que describa diagnóstico específico, localización, estadio y extensión de la enfermedad; evolución clínica; tratamientos realizados, actuales y pendientes; respuesta terapéutica; pronóstico; secuelas y compromiso funcional asociado.	-Informe Anatomo Patológico -Secuelas específicas, según el órgano comprometido -Escala ECOG -Índice de Karnofsky	FÍSICO
Enfermedades Cardíacas. (ICC, Arritmias, Infarto Agudo del Miocardio, etc)	Méd. Gral./Esp. y/o T.O., Klgo., Flgo., Psic. o Enf. Debe aportar antecedentes actualizados que describan diagnóstico, evolución y gravedad de la enfermedad, función cardíaca objetiva (disnea, fatiga, angina, palpitaciones, síncope, intolerancia al esfuerzo y limitaciones para las actividades de la vida diaria) tratamiento realizado y actual, eventos cardiovasculares relevantes y repercusión en las actividades de la vida diaria.	- Ecocardiograma - Capacidad funcional - Clasificación funcional NYHA	FÍSICO

Enfermedades Respiratorias (EPOC, LCFA, Asma, Fibrosis pulmonar, etc)	Méd. Gral./Esp. y/o T.O., Klg., Flgo., Psic. o Enf. Debe aportar antecedentes clínicos que describan diagnóstico y evolución de la enfermedad respiratoria, grado de severidad, pruebas de función pulmonar, exacerbaciones, tratamiento realizado y actual, y repercusión funcional, incluyendo limitación para el esfuerzo y actividades de la vida diaria.	-Espirometría -VEF1 (% predicho) -Saturación de O ₂ -Necesidad de O ₂ - TAC de tórax	
Demencia / Deterioro cognitivo / Trastorno Neurocognitivo	Neurólogo/a, Psiquiatra, Geriatra o Médico/a tratante del Programa de Salud Mental, Programa de Memoria, Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa (Postrados) o PADI. (Es admisible si se indica que es parte de alguno de estos programas). Debe aportar informe actualizado que describa tipo y causa del trastorno neurocognitivo, gravedad, tiempo de evolución, compromiso de memoria y otras funciones cognitivas, síntomas conductuales o emocionales, tratamientos y pronóstico. Debe especificar repercusión en la autonomía, seguridad, manejo de medicamentos y dinero, orientación, actividades de la vida diaria, necesidad de supervisión y asistencia de terceros.	- índice de Barthel - Escala de Lawton y Brody - Cuestionario de Pfeiffer - MMSE, MoCA - Debe identificarse al informante o cuidador. - Informe de neuroimagen -Ayuda Técnica	MENTAL PSÍQUICO
Daño orgánico cerebral	Méd. Gral./Esp. y/o T.O., Klg., Flgo., Psic. o Enf. Debe aportar informe actualizado que especifique la causa, diagnóstico neurológico, fecha de inicio, localización y extensión de la lesión, evolución y carácter estable o progresivo. Debe describir secuelas cognitivas, conductuales, motoras, sensitivas, visuales, del lenguaje, habla o deglución; presencia de epilepsia; tratamientos, rehabilitación, ayudas técnicas, autonomía y necesidad de supervisión o asistencia de terceros.	-Índice de Barthel - Escala de Lawton y Brody -Informe de neuroimagen -Ayuda Técnica	MENTAL PSÍQUICO
Discapacidad Intelectual	De 6 a 18 años: Psicometría (WAIS-WISC) o Informe descriptivo de Psicólogo que indique grado de Discapacidad Intelectual (Ej: Leve, moderada, severa) Mayores de 18: Psicometría (WAIS) o Informe descriptivo de Psicólogo o informe de Psiquiatra o Neurólogo o Médico Programa de Salud Mental Se aceptarán diagnósticos de especialistas que especifican el CI, sin psicometría: Sólo por neurólogo o psiquiatra con informe descriptivo.		MENTAL INTELECTUAL

Trastorno del Espectro Autista	Psiqiatra o Neurólogo Debe aportar informe actualizado que describa fundamentos del diagnóstico, nivel de apoyo requerido —1, 2 o 3—, desarrollo cognitivo y del lenguaje, comorbilidades, tratamientos, medicamentos y evolución. Debe especificar limitaciones.	-Autocuidado -Aprendizaje -Flexibilidad -Desregulaciones -Participación familiar, escolar, social o laboral - Necesidad de supervisión	MENTAL PSÍQUICO
Depresión / Trastorno mixto de ansiedad y depresión	Psic./Méd. Programa Salud Mental, Psic. Debe aportar información actualizado que describa diagnóstico específico, gravedad, fecha de inicio, evolución, recurrencias, síntomas actuales, comorbilidades, riesgo suicida, hospitalizaciones, tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos, adherencia, respuesta, efectos adversos y pronóstico. Debe especificar la repercusión la funcionalidad.	-Autocuidado -Concentración -Relaciones interpersonales -Participación Social -Desempeño Educativo o laboral	MENTAL PSÍQUICO
Trastorno Bipolar, Trastorno Esquizoafectivo, Trastornos de la Personalidad, Esquizofrenia	Psic./Méd. Programa Salud Mental, Psic. Debe aportar informe actualizado que describa diagnóstico, fecha de inicio, evolución, síntomas actuales, descompensaciones, episodios afectivos o psicóticos, hospitalizaciones, comorbilidades, consumo de sustancias, tratamiento farmacológico y psicosocial, adherencia, respuesta, efectos adversos y pronóstico. Debe especificar la repercusión en la funcionalidad.	-Autocuidado -Concentración -Relaciones interpersonales -Participación Social -Desempeño Educativo o laboral -Manejo del dinero -Necesidad de supervisión o asistencia de terceros	MENTAL PSÍQUICO
Trastornos por Abuso de Sustancias	Psic./Méd. Programa Salud Mental, Psic. Debe aportar informe actualizado que identifique las sustancias consumidas, patrón, gravedad y tiempo de evolución; fecha del último consumo, períodos de abstinencia, recaídas, episodios de intoxicación, abstinencia o sobredosis, hospitalizaciones y tratamientos realizados. Debe describir comorbilidades psiquiátricas y médicas, secuelas cognitivas, neurológicas o físicas, adherencia, respuesta terapéutica y pronóstico.	-Autocuidado -Desempeño Laboral -Relaciones familiares y social -Necesidad de supervisión -Manejo de Dinero	
Enfermedad de Parkinson	Méd. Gral./Esp. y/o T.O., Klg., Flgo., Psic. o Enf. Debe aportar informe actualizado que describa fecha de inicio, evolución, etapa de la enfermedad, síntomas motores y no motores, fluctuaciones “on-off”, discinesias, alteraciones de marcha y equilibrio, caídas, compromiso cognitivo, del habla o deglución; tratamientos, respuesta y rehabilitación.	-Índice de Barthel - Escala de Lawton y Brody -Ayuda Técnica -Necesidad de supervisión o asistencia de terceros	FÍSICO

Enfermedad Renal Crónica en diálisis	Méd. Gral./Esp. y/o T.O., Klg., Flgo., Psic. o Enf. Debe aportar información que describa causa de la enfermedad renal , etapa, fecha de inicio y modalidad de diálisis —hemodiálisis o peritoneo diálisis—, frecuencia, acceso vascular o peritoneal, adherencia, tolerancia, complicaciones, hospitalizaciones, tratamientos y eventual condición para trasplante .	-Hemodiálisis -Diálisis Peritoneal -Condición para Trasplante -Informe nefrológico -Ceroteca	FÍSICO
Epilepsia	Neurólogo Debe aportar informe actualizado que describa tipo y causa de la epilepsia, edad de inicio, características, frecuencia y duración de las crisis, alteración de conciencia, fecha de la última crisis, período posictal, lesiones asociadas, episodios de estatus epiléptico, factores desencadenantes y grado de control. Debe señalar tratamiento, adherencia, respuesta, efectos adversos, hospitalizaciones, comorbilidades cognitivas o conductuales y necesidad de supervisión.	-Electroencefalograma -Informe de neuroimagen - Necesidad de supervisión	MENTAL PSÍQUICO
Fibromialgia	Méd. Gral./Esp. y/o T.O., Klg., Flgo., Psic. o Enf. Debe aportar informe actualizado que describa tiempo de evolución, dolor generalizado, fatiga, alteraciones del sueño y cognitivas, síntomas asociados, comorbilidades, tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, adherencia, respuesta y pronóstico. Debe especificar la repercusión en la movilidad, tolerancia al esfuerzo, actividades de la vida diaria y desempeño social o laboral.	- Índice de dolor generalizado (WPI) -Repercusiones de la movilidad -Tratamiento Farmacológico	FÍSICO
Hipoacusia	Méd. Gral./Esp. y/o T.O., Klg., Flgo., Psic. o Enf. Debe contar con Audiometría	-Audiometría. -Potencial Evocado	SENSORIAL AUDITIVO
	Se aceptará GES confirmado en lugar de audiometría, sólo si cuenta con: Diagnostico confirmado, que indique lateralidad y severidad.		
	En caso de que sea un diagnóstico secundario, se aceptará informe diagnóstico de Otorrinolaringología, sin audiometría, a cualquier edad.		
	Menores sin lenguaje: potencial evocado auditivo o examen BERA		
Disautonomía	Méd. Gral./Esp. y/o T.O., Klg., Flgo., Psic. O Enf. Debe aportar resultado de la prueba de mesa basculante (Tilt Test) y/o informe cardiológico complementario actualizado que fundamente el diagnóstico y describa su repercusión funcional.	- Tilt Test	FÍSICO

Artritis Reumatoide	Méd. Gral./Esp. y/o T.O., Klgo., Flgo., Psic. o Enf. Debe aportar informe actualizado que describa tiempo de evolución, articulaciones comprometidas, actividad de la enfermedad, dolor, rigidez matinal, inflamación, deformidades, pérdida de fuerza y rango articular; manifestaciones extraarticulares, tratamientos realizados y actuales, adherencia, respuesta, cirugías, ayudas técnicas y pronóstico.	-Informe imagenológico de la articulación afectada -Epicrisis o Protocolo Operatorio -Ayuda Técnica	
Patologías de columna	Méd. Gral./Esp. y/o T.O., Klgo., Flgo., Psic. o Enf. Debe aportar informe actualizado que describa diagnóstico, segmento comprometido —cervical, dorsal o lumbar—, causa, tiempo de evolución, dolor, limitación de movilidad, alteraciones de fuerza o sensibilidad, radiculopatía, compromiso medular, marcha, tratamientos realizados, respuesta, cirugías, rehabilitación, ayudas técnicas y pronóstico. Debe especificar la repercusión en las actividades de la vida diaria y la necesidad de asistencia de terceros.	-Informe imagenológico RX, TAC, Resonancia. -Electromiografía -Ayuda Técnica	FÍSICO
Síndrome de Tourette	Méd. Gral./Esp. y/o T.O., Klgo., Flgo., Psic. o Enf. Debe aportar informe que describa edad de inicio, tipos de tics motores y vocales, frecuencia, intensidad, duración, variabilidad, capacidad de supresión, factores desencadenantes, lesiones o dolor asociados y evolución.	-Repercusión en las actividades de la vida diaria (relaciones sociales y desempeño escolar o laboral) -Escala Global de Gravedad de Tics de Yale (YGTSS)	MENTAL PSÍQUICO
Obesidad mórbida u obesidad clase III	Méd. Gral./Esp. y/o T.O., Klgo., Flgo., Psic. o Enf. Debe aportar informe actualizado que consigne peso, talla, índice de masa corporal (IMC), tiempo de evolución, tratamientos realizados, respuesta y eventual indicación de cirugía bariátrica. Debe describir comorbilidades y complicaciones metabólicas, cardiovasculares, respiratorias, osteoarticulares o psicológicas, además de limitaciones para la marcha, movilidad, autocuidado y actividades de la vida diaria.	-Indicar IMC -Autocuidado -Ayuda Técnica	FÍSICO
VIH	Méd. Gral./Esp. y/o T.O., Klgo., Flgo., Psic. o Enf. Debe aportar informe actualizado que describa fecha de diagnóstico, etapa clínica, tratamiento antirretroviral, adherencia, respuesta y efectos adversos, infecciones oportunistas, neoplasias, hospitalizaciones, comorbilidades y secuelas neurológicas, cognitivas, físicas o nutricionales. Debe especificar la repercusión en las actividades de la vida diaria y desempeño social o laboral.	-Desempeño Social y Laboral -Autocuidado -Funciones Cognitivo -Síndrome de Consuntivo	FÍSICO

Visual	Informe Oftalmólogo o Agudeza visual (con corrección) o Informe campo visual o receta lentes o fondo de ojo. *Si el oftalmólogo indica CEGUERA LEGAL con patología asociada: evaluar y pasar a comisión, no pedir agudeza visual. Menores: potencial evocado visual Cuando no hay agudeza visual: - Vicio de refracción (VR) sin patología asociada: Se rechaza, no constituye discapacidad, si quiere apelar debe adjuntar agudeza visual - VR con patología asociada: Evaluar funcionalidad y determinar porcentaje. Casos antiguos asociados a VR (ingresados el 2024): Aplicar tabla de agudeza visual para valoración, evaluar y pasar a comisión, no pedir agudeza visual. Comisión podría pedir adjuntar agudeza visual, dependiendo del caso.		SENSORIAL VISUAL
Afasia	Neurólogo o Fonoaudiólogo Debe aportar informe actualizado que especifique la causa —ACV, traumatismo, tumor, enfermedad neurodegenerativa u otra—, fecha de inicio, tipo y gravedad de la afasia, evolución, tratamientos y rehabilitación. Debe describir el compromiso de comprensión, expresión oral, denominación, repetición, lectura y escritura, además de su repercusión en la comunicación cotidiana, autonomía y participación social o laboral. La afasia debe consignarse como una secuela o trastorno del lenguaje, identificando siempre la enfermedad que la origina.	- Informe de neuroimagen -Autonomía -Repercusión en las actividades de la vida diaria -Necesidad de asistencia de terceros	MENTAL PSÍQUICO

PATOLOGÍAS QUE CURSAN CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SU GRADO DE SEVERIDAD PUEDEN SER CONSIDERADAS CON ORIGEN MENTAL INTELECTUAL SIN CONSIDERAR PSICOMETRÍA:

1. Severidad Profunda a Severa

Dependencia casi total – compromiso cognitivo profundo + múltiples comorbilidades

- Síndrome de Patau
 - DI profunda
 - Malformaciones graves (SNC, cardíacas)
 - Alta mortalidad precoz
- Síndrome de Edwards
 - DI severa
 - Compromiso multisistémico
 - Sobrevida muy limitada
- Síndrome de Angelman
 - DI severa–profunda
 - Lenguaje muy limitado o ausente
 - Epilepsia + alteración motora
- Síndrome de Rett
 - Regresión neurológica
 - Pérdida de habilidades adquiridas
 - Dependencia progresiva
- Síndrome de Cornelia de Lange
 - DI moderada a severa
 - Malformaciones múltiples
 - Compromiso conductual importante
 - Alta dependencia
- Síndrome de Aicardi
 - DI severa a profunda
 - Epilepsia de difícil manejo
 - Compromiso neurológico grave
 - Dependencia total
- Síndrome de Cri du Chat
 - DI moderada a severa
 - Retraso global del desarrollo
 - Lenguaje muy limitado
 - Alta dependencia funcional
- Síndrome de Smith-Lemli-Opitz
 - DI moderada a severa
 - Malformaciones congénitas
 - Trastornos conductuales
 - Dependencia variable (frecuente apoyo continuo)

2. SEVERIDAD LEVE- MODERADA

- Síndrome de Down
 - DI leve-moderada, puede llegar a ser límite
 - Buen desarrollo social
 - Pueden lograr autonomía parcial
- Síndrome de Williams
 - DI leve-moderada, en algunos caso puede ser límite
 - Perfil cognitivo desigual
 - Mayor autonomía que otros síndromes
- Síndrome de Prader-Willi
 - DI leve-moderada en algunos casos limite
 - Gran impacto conductual (hiperfagia, impulsividad)
 - Alta dependencia en autocuidado
- Síndrome de Kabuki
 - DI leve a moderada, en algunos casos límite
 - Retraso del desarrollo
 - Buen potencial de adaptación
 - Autonomía parcial con apoyo
- Síndrome X frágil
 - DI moderada a normal bajo
 - Frecuente asociación con Trastorno del espectro autista
 - Dificultades conductuales relevantes
 - Debes evaluar caso a caso / Deben traer Psicometría o IBMF de especialista
 - La DI es común, pero no siempre presente o con distinta severidad

3. OTROS DIAGNÓSTICOS

- Síndrome de Noonan: Normal a límite
- Esclerosis tuberosa: Normal o límite
- Neurofibromatosis tipo 1: Normal o límite
- Síndrome de Turner: DI rara
- Microcefalia: Variable.
- Hidrocefalia congénita: Variable

Trastornos metabólicos (muchos cursan con DI si no se tratan precozmente)

- Fenilcetonuria
- Hipotiroidismo congénito
- Enfermedad de Tay-Sachs